

# Physioguide — Clínica — UCL medial de codo (lanzadores)

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Moving valgus, milking, valgo 0°/30°; cluster C — elbow-wrist-tests-expansion.md

Principles: Master clinical document

---

## 1. DEFINITION

Insuficiencia del UCL (MCL) de codo = dolor e/o inestabilidad medial por lesión del ligamento colateral cubital, típica en lanzadores overhead (béisbol, jabalina, algunos tenistas de servicio) o trauma en valgo.

No es sinónimo de epicondialgia medial, aunque coexisten. No es túnel cubital, aunque el nervio cubital corre junto al UCL.

---

## 2. TYPICAL LOCATION

Dolor en epicóndilo medial / trayecto del UCL, a menudo en la fase de aceleración del lanzamiento.

---

## 3. HISTORY

- Deporte de lanzamiento, volumen, cambio de mecánica
  - Dolor medial en aceleración; pérdida de velocidad o control
  - Sensación de “se abre” o pop medial
  - Parestesias 4.º–5.º (cubital concomitante)
  - Trauma único en valgo vs insidioso
  - Pregunta: «¿Duele por dentro del codo justo al acelerar el lanzamiento?»
- 

## 4. MECHANISM

- Mecanismo — Hipótesis !'
  - Valgo repetido overhead — UCL
  - Flexión/pronación laboral sin lanzar — Epicondialgia medial
  - Apoyo de codo + hormigueo 4.º–5.º — Cubital
  - Joven + dolor lateral + bloqueo — OCD capitellum (otro árbol)
- 

## 5. CLUSTER

LANZAMIENTO / VALGO

+ DOLOR MEDIAL FAMILIAR EN ACELERACIÓN

+ MOVING VALGUS ± MILKING ± VALGO A ~30°

± TINEL CUBITAL (coexistencia)

!' UCL COMPATIBILITY !' (clínica, no RMN)

---

## 6. DIFFERENTIAL

- Epicondialgia medial (carga flexor-pronador, menos inestabilidad)
  - Neuropatía cubital
  - Avulsión ósea / epifisiólisis en adolescente
  - Artrosis medial
  - PLRI (posterolateral, no medial)
- 

## 7. AI RULES

- No «rotura de UCL confirmada» por moving valgus.
- No tratar solo como codo de golfista en lanzador con valgo dinámico.
- Cubital puede coexistir: territorio 4.º–5.º.

- Derivación/imagen si inestabilidad, pop, o fracaso conservador.
- No inventar LR del moving valgus; citar O'Driscoll 2005 como descripción del test en atletas overhead.

Citation: O'Driscoll SW, Lawton RL, Smith AM. \*Am J Sports Med.\* 2005. Literatura UCL reconstruction / Tommy John (contexto, no protocolo quirúrgico en app).



